

# Infecciones virales (Herpes simple y zóster, verrugas, condilomas, molluscum contagiosum y exantemas virales)

---

## 1. Introducción y relevancia clínica

Las **infecciones virales cutáneas** son extremadamente frecuentes en la práctica clínica y representan una causa común de consulta en **atención primaria y dermatología**.

La piel es una de las principales puertas de entrada y manifestación de infecciones virales sistémicas.

Algunas son **autolimitadas y benignas**, mientras que otras pueden tener **reactivaciones recurrentes o complicaciones severas**, especialmente en inmunodeprimidos.

Los agentes más comunes son:

- **Virus Herpes simplex (VHS-1, VHS-2)**
- **Virus Varicela-Zóster (VVZ)**
- **Virus del Papiloma Humano (VPH)**
- **Poxvirus (Molluscum contagiosum)**
- **Virus respiratorios o exantemáticos (sarampión, rubéola, varicela, escarlatina)**

Su diagnóstico es fundamentalmente **clínico**, apoyado en la **morfología y distribución de las lesiones**, aunque en casos atípicos pueden requerirse exámenes virológicos o biopsia.

---

## 2. Fisiopatología y bases conceptuales

### 2.1. Mecanismos de infección cutánea viral

1. **Inoculación directa** del virus en la piel o mucosas (ej. herpes simple).
2. **Diseminación hematógena** tras infección respiratoria o sistémica (ej. varicela, sarampión).
3. **Reactivación de virus latentes** en ganglios nerviosos (ej. herpes zóster).
4. **Proliferación celular inducida por virus** (ej. VPH en verrugas o condilomas).

## 2.2. Respuesta inmunológica

El control viral depende de la inmunidad celular. En inmunodeprimidos (VIH, trasplantes, neoplasias), las infecciones virales cutáneas son **más graves, extensas y persistentes**.

---

## 3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

### 3.1. Herpes simple (VHS-1, VHS-2)

#### Etiología

- VHS-1: principalmente orofacial.
- VHS-2: genital.

Ambos pueden intercambiar localización.

#### Fisiopatología

Tras la infección inicial, el virus permanece **latente en ganglios sensoriales** y se reactiva ante fiebre, estrés, inmunosupresión o radiación UV.

#### Clínica

- **Primoinfección:** lesiones vesiculares dolorosas sobre base eritematosa; puede acompañarse de fiebre y adenopatías.
- **Recurrencias:** menos extensas, localizadas y autolimitadas.
- Localización típica: labios, mucosa oral, genitales, región glútea o periocular.
- Vesículas → pústulas → costras → curan sin cicatriz.

#### Diagnóstico diferencial

- Impétigo ampolloso.
- Aftas orales.
- Varicela (vesículas diseminadas).

#### Complicaciones

- Eczema herpético (en atópicos).
  - Encefalitis herpética.
  - Queratitis herpética.
- 

## 3.2. Herpes zóster (culebrilla)

### Etiología

Reactivación del **Virus Varicela-Zóster (VVZ)**, que permanece latente en los ganglios de raíces dorsales.

### Clínica

- Dolor neuropático intenso, ardor o prurito **precede 2–3 días** a la erupción.
- Lesiones vesiculares agrupadas en racimos **distribuidas en un dermatoma** unilateral.
- Fases: máculas → vesículas → pústulas → costras.
- No cruza la línea media corporal.
- Zóster oftálmico (compromiso de rama oftálmica del trigémino) puede causar queratitis o uveítis.

### Diagnóstico diferencial

- Herpes simple localizado.
- Dermatitis de contacto.
- Foliculitis herpetiforme.

### Complicaciones

- **Neuralgia postherpética** (dolor > 3 meses).
- Infección bacteriana secundaria.
- Compromiso ocular o neurológico.

---

### 3.3. Verrugas vulgares (VPH)

#### Etiología

Virus del Papiloma Humano (VPH), principalmente **tipos 1, 2, 4, 27 y 57**.

#### Fisiopatología

Infección de queratinocitos con **proliferación epidérmica benigna**. Se transmite por contacto directo o fómites.

#### Clínica

- Pápulas o nódulos **hiperqueratósicos, ásperos, del color de la piel o grisáceos**.
- Localización: dedos, dorso de manos, rodillas, planta del pie (verruca plantar).
- Verrugas planas: pápulas lisas, pequeñas, múltiples, en cara o dorso de manos.

#### Diagnóstico diferencial

- Callos o helomas (sin puntos hemorrágicos).
- Molluscum contagiosum (umbilicado).
- Queratosis seborreica juvenil.

#### Evolución

Pueden resolverse espontáneamente en 6–12 meses, pero tienden a recidivar.

---

### 3.4. Condilomas acuminados

#### Etiología

VPH **tipos 6 y 11** (benignos).

Transmisión **sexual o perinatal**.

#### Clínica

- Lesiones papilomatosas, blandas, de aspecto **verrucoso o coliflorado**, color rosado o gris.

- Localización: genitales externos, perianal, uretra, cuello uterino.
- Asintomáticos o con prurito, sangrado o irritación.

#### **Diagnóstico diferencial**

- Condilomas planos de sífilis secundaria.
- Molusco contagioso.
- Papilomas escamosos benignos.

#### **Complicaciones**

- Riesgo oncogénico bajo (tipos 6 y 11).
- VPH 16, 18, 31, 33 asociados a cáncer cervicouterino y anal.

---

### **3.5. Molluscum contagiosum**

#### **Etiología**

Virus del género *Poxvirus* (DNA).

Transmisión por contacto directo o fómites; frecuente en **niños, adultos jóvenes y pacientes VIH positivos**.

#### **Clínica**

- Pápulas perladas, umbilicadas, de 2–5 mm, lisas, con contenido blanquecino central.
- Localización: tronco, axilas, genitales, cara.
- Indoloras, ocasionalmente pruriginosas.
- En inmunodeprimidos pueden ser grandes o diseminadas.

#### **Diagnóstico diferencial**

- Verrugas planas.
- Acné.

- Queratoacantomas pequeños.

### Evolución

Autolimitada (3–12 meses).

Puede dejar cicatriz umbilicada residual.

---

## 3.6. Exantemas virales clásicos

### Sarampión

- Fiebre alta, tos, conjuntivitis, manchas de Koplik.
- Exantema **maculopapular descendente** (inicia en cara y se extiende).
- Causa: Virus del sarampión (Morbillivirus).

### Rubéola

- Exantema maculopapular tenue, fiebre leve, adenopatías retroauriculares.
- Riesgo de **síndrome de rubéola congénita** en embarazadas.

### Varicela

- Lesiones **en distintos estadios evolutivos** (mácula, vesícula, pústula, costra).
- Distribución centrípeta (más en tronco).
- Complicaciones: sobreinfección bacteriana, neumonía, encefalitis.

### Escarlatina

- Exantema **puntiforme difuso** con lengua aframbuesada.
  - Etiología: *S. pyogenes* (toxina eritrogénica).
- 

## 4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

| Prueba                                     | Utilidad                                                | Indicaciones                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Tinción de Tzanck</b>                   | Detecta células multinucleadas en VHS / VVZ             | Diagnóstico rápido de lesiones vesiculares        |
| <b>PCR viral</b>                           | Alta sensibilidad y especificidad                       | Confirmación en cuadros graves o inmunodeprimidos |
| <b>Biopsia cutánea</b>                     | Histología específica (inclusiones intranucleares)      | Lesiones atípicas o tumorales                     |
| <b>Cultivo viral</b>                       | Poco usado (tarda varios días)                          | Casos complejos                                   |
| <b>Test de VPH (PCR o captura híbrida)</b> | Detección de tipos oncogénicos                          | Lesiones genitales o cervicales                   |
| <b>Luz de Wood</b>                         | No específica para virus, pero útil para DD pigmentario | —                                                 |

---

## 5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

### 5.1. Herpes simple

- **Antiviral sistémico:**
    - Aciclovir 400 mg VO cada 8 h × 7–10 días (primoinfección).
    - En recurrencias: 400 mg VO cada 8 h × 5 días o profilaxis si ≥6 episodios/año.
  - **Tópico:** aciclovir 5% (eficacia limitada).
  - Evitar contacto y relaciones sexuales durante el brote activo.
-

## 5.2. Herpes zóster

- **Antivirales sistémicos:**
    - Aciclovir 800 mg VO cada 5 h × 7–10 días.
    - Alternativas: valaciclovir 1 g cada 8 h o famciclovir 500 mg cada 8 h.
    - Iniciar **antes de 72 h del rash** para reducir neuralgia postherpética.
  - **Analgesia:** AINES, gabapentina o pregabalina en dolor neuropático.
  - **Prevención:** vacuna recombinante anti-Zóster (≥50 años).
- 

## 5.3. Verrugas vulgares y condilomas

- **Destrucción local:** crioterapia, ácido salicílico, electrocauterio o láser.
  - **Tratamiento químico:** podofilina, ácido tricloroacético (ATC).
  - **Inmunomodulación tópica:** imiquimod 5% (3 veces/semana por 8–12 sem).
  - **Prevención:** vacuna tetravalente o nonavalente contra VPH (programa MINSAL desde 4º básico).
- 

## 5.4. Molluscum contagiosum

- Habitualmente autolimitado.
  - Opciones terapéuticas:
    - Curetage o crioterapia si estético o contagioso.
    - Imiquimod o ácido salicílico tópicos.
    - En VIH: tratamiento antirretroviral + manejo dermatológico.
- 

## 5.5. Exantemas virales



- Tratamiento sintomático (antitérmicos, hidratación, reposo).
- Prevención mediante **vacunación universal**: SRP (sarampión, rubéola, parotiditis) y varicela.

---

## 6. Complicaciones y pronóstico

| Infección             | Complicaciones principales                | Pronóstico                              |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Herpes simple         | Eczema herpético, encefalitis, queratitis | Recurrente pero benigno                 |
| Herpes zóster         | Neuralgia postherpética, encefalitis      | Excelente con antivirales precoces      |
| Verrugas / condilomas | Recurrencia, displasia cervical           | Benigno; riesgo oncológico si VPH 16/18 |
| Molluscum contagiosum | Diseminación en inmunodeprimidos          | Autolimitado                            |
| Exantemas virales     | Neumonía, encefalitis, glomerulonefritis  | Generalmente autolimitados              |

---

## 7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



### Perlas clínicas

1. **Herpes simple:** vesículas agrupadas sobre base eritematosa, dolorosas, recidivantes.

2. **Herpes zóster:** lesiones **unilaterales y dermatomales**, no cruzan la línea media.
3. **Verrugas vulgares:** superficie áspera con **puntos hemorrágicos negros**.
4. **Condilomas:** aspecto “coliflorado”, blandos, rosados.
5. **Molluscum contagiosum:** pápulas umbilicadas perladas, autolimitadas.
6. En exantemas virales, el **patrón de distribución** orienta al diagnóstico (descendente en sarampión, centrípeto en varicela).
7. En herpes zóster, iniciar antivirales **antes de 72 h** para prevenir neuralgia postherpética.



## Errores comunes

- Confundir impétigo con herpes simple.
- No indicar antivirales en zóster severo o inmunodeprimido.
- Tratar verrugas planas con corticoides (empeora).
- No educar sobre **autoinoculación** o **transmisión sexual** del VPH.
- No vacunar a población objetivo contra VPH o SRP.

---

## 8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las infecciones virales cutáneas más frecuentes son **herpes simple, zóster, VPH y molluscum contagiosum**.
2. El diagnóstico es **clínico**, apoyado por PCR o tinción de Tzanck si es necesario.
3. **Aciclovir** es el antiviral de elección para herpes simple y zóster.
4. **VPH 6 y 11** causan condilomas; **16 y 18** se asocian a cáncer cervicouterino.
5. **Molluscum contagiosum** es autolimitado pero requiere tratamiento en inmunodeprimidos.

6. Los **exantemas virales clásicos** (sarampión, rubéola, varicela) se previenen mediante vacunación.
7. Reconocer **patrones típicos de distribución** es clave para el diagnóstico en EUNACOM.